★★☆急性阑尾炎（0~3题）

- 青年人淋巴滤泡明显增生等→阑尾阻塞（2020）
- 突发转移性右下腹痛和 / 或右下腹固定压痛（2008、2015）
  发热、WBC ↑
  - 并发化脓性门静脉炎、细菌性肝脓肿：
    肝大、剑突下压痛、可有黄疸，B 超→穿刺
  - 可能可能最可能（2011）
- 试验（2023）
  - ①结肠充气试验 Rovsing 征：提示阑尾炎，但阴性也不能排除诊断
  - ②腰大肌试验 Psoas 征（患者左侧卧位）：提示阑尾位置深（盲肠后位 / 腹膜后位）
  - ③闭孔内肌试验 Obturator 征（患者仰卧位）：提示阑尾位置低（盆位）“闭 b- 仰 - 低”
- 发展和治疗
  - 单纯性 — 切阑尾，不冲腹腔、不放引流
  - 化脓性
    - 局部肌紧张、腔内积脓
    - 脓液少→纱布沾干渗液后切阑尾，不冲腹腔、不放引流
      脓液多→生理盐水冲腹腔后切阑尾，根据情况放引流（2012）
    - 麦氏点切口
  - 坏疽穿孔性（2025）
    - 腹痛可暂时减轻、但随即弥漫性腹膜炎（全腹压痛反跳痛肌紧张）
      体温进一步升高、肠鸣音↓、甚至休克
    - 生理盐水冲腹腔后切阑尾，根据情况放引流
    - 右下腹经腹直肌切口（2025）
  - 腹盆腔脓肿
    - 阑尾周围脓肿
      - 右下腹包块：波动感、压痛、边界不清、活动度差
      - 三代头孢 + 甲硝唑、穿刺 / 置管引流，若脓肿扩大行手术切开引流，3 个月后切阑尾
    - 盆腔脓肿 — 肛门下坠感、直肠刺激征（里急后重）和 / 或膀胱刺激征（尿频尿急尿痛）（2009、2025）
- 治疗
  - 一旦确诊早期手术切阑尾（但阑尾周围脓肿除外，2016）
  - 围术期用抗生素
  - 手术并发症
    - ①切口感染：最常见
    - ②腹腔内出血：多在术后 1 天内“你搞的”，血容量降低 + 轻度腹膜炎，腹腔穿刺抽出不凝血
    - ③粘连性肠梗阻：痛、吐、胀、停
    - ④阑尾残株炎
    - ⑤粪瘘
- 特殊类型阑尾炎
  “老幼病孕”
  （2007、2009、2013、2016、2022）
  - 体征不典型、病情重、发展快，须尽早手术
  - 新生儿：最易穿孔
  - 小儿：腹痛等症状明显
  - HIV 感染者：WBC 多不高
  - 老年人：感觉迟钝
  - 妊娠 — 手术切口偏高，需加黄体酮，不放引流。临产期（37 周左右）可剖宫产 + 切阑尾